Établissement

Médecin responsable

PROTOCOLE DE SOINS INFIRMIERS D'URGENCE — ARTICLE R.4311-7 CSP

Crise convulsive prolongée – Midazolam buccal

Adulte et enfant épileptiques · le plan nominatif (neurologue, pédiatre, PAI) prime pour la dose et le délai

URGENCE VITALE → 15 IMMÉDIAT · crise ≥ 5 min ou répétée sans reprise de conscience ; première crise ; apnée, cyanose ; traumatisme ; grossesse.

J'applique si

- Crise convulsive **≥ 5 min** (ou durée du plan individuel) chez un épileptique connu.
- Crises en salves **sans reprise de conscience** entre elles.

Je n'applique pas → avis médical

- Buccolam : allergie aux BZD, **myasthénie**, insuffisance respiratoire sévère, **SAOS**, IH sévère.
- Nourrisson de 3 à < 6 mois : hôpital uniquement.
- **2e benzodiazépine** sans prescription du 15.
- ≥ 60 ans, insuffisance rénale ou cardiaque : possible, surveillance respiratoire renforcée.

J'agis

ACTES CONSERVATOIRES (R4311-7)

1. Noter l'**heure de début**, chronométrer ; renfort ; protéger sans contenir, rien dans la bouche.
2. Respiration, cyanose, SpO2, traumatisme ; **glycémie capillaire**.

SUR CE PROTOCOLE D'URGENCE

3. **≥ 5 min** : **Buccolam** nominatif (dose ci-contre), entre gencive et joue, lentement ; **15**.
4. **Une seule dose.** Crise qui persiste 10 min après : 15 déjà prévenu, aucune 2e dose sans son ordre.

ACTES CONSERVATOIRES (R4311-7)

5. Après la crise : **PLS**, voies aériennes, aspiration ; O2 si SpO2 < 94 %.

SUR ORDRE DU 15

6. Chariot DOTR : midazolam IM, clonazépam IV ou diazépam intrarectal (carte ci-contre).

Consigne orale du 15 ou du médecin → télé-prescription écrite, annexée au dossier.

Doses

Buccolam (buccal)

6 mois–1 an **2,5 mg** · 1–5 ans **5 mg**

5–10 ans **7,5 mg** · ≥ 10 ans **10 mg**

Sur ordre du 15 (chariot DOTR)

- Midazolam IM **0,15 mg/kg**, max 10 mg (hors AMM, RFE 2018)
- Clonazépam IV lente : dose du 15 (RFE : 0,015 mg/kg, max 1,5 mg)
- Enfant : diazépam intrarectal **0,5 mg/kg**, max 10 mg

J'appelle le médecin

- Toute utilisation du Buccolam : réévaluer le plan individuel.
- Crise brève inhabituelle, fièvre, changement de traitement.

Je surveille et je trace

- Respiration, SpO2, conscience **toutes les 5 min** jusqu'au réveil complet ; ventilation au masque prête.
- Début et fin de crise, dose, heure, effet ; seringue remise aux secours.
- **Compte rendu écrit, daté, signé**, remis au médecin (R4311-7).

À retenir : 5 minutes de crise = Buccolam + 15. Une seule dose sans ordre du 15 : sédation et dépression respiratoire possibles.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature et cachet du médecin :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : Art. R4311-7 CSP ; EMA, RCP Buccolam (II/0061, 10/2024 ; AMM adulte) ; HAS, avis CT Buccolam 02/09/2025 ; RFE SRLF/SFMU/GFRUP état de mal épileptique 2018 ; RCP Rivotril 1 mg/1 mL inj. (ANSM, MAJ 22/04/2025), Midazolam Aguettant 5 mg/mL (MAJ 16/08/2023), Valium 10 mg/2 mL (MAJ 19/01/2024) ; outil chariot d'urgence DOTR (09/2026).

Réf. DOTR-IDE-EPI | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature